

❖ 환자 안내/생활 습관 교육

- ① 금연 및 유해 환경(담배연기, 화학물질, 강한 냄새)을 피하는 것이 가장 중요함을 강조 → 금연이 힘들다는 것을 안다고 이야기하며 공감해 주기
- ② 천식, COPD 환자는 독감 및 폐렴쌍구균 예방접종을 하는 것이 필요함을 설명
- ③ 알레르기 의심 시 환경 관리의 중요성을 강조
 - 집안은 자주 청소를 하되 청소는 먼지가 많이 날리지 않도록 물걸레나 진공청소기를 이용
 - 이불, 매트리스 커버를 주 1회 섭씨 55℃ 이상의 뜨거운 물로 세탁한 후 말려서 사용한다.
 - 실내 습도를 40~50%로 유지하여 집먼지진드기의 번식을 막기
 - 카펫, 두꺼운 천으로 된 소파나 커튼 등은 사용하지 않고 애완동물 기르지 않도록
 - 밖에 나갔다 들어오면 옷을 갈아입기
- ④ 폐암을 배제할 수 없는 경우, 영상검사와 폐기능검사를 통해 정확한 진단을 하도록 교육
- ⑤ 고열, 화농성 객담, 호흡곤란 증상 심해지면 입원 치료 필요할 수 있음을 교육



keyword

급성과 만성에 따라, 흡연 여부에 따라 감별 진단하기

기침의 특성, 가래, 콧물/코막힘, 열에 대해 자세히 병력 청취

흡연력, 나이, 악화 요인 꼭 확인하기

금연+대증 치료+유발 요인 회피

흡연자는 금연 교육을 반드시 시행하고, 천식/COPD 증례는 기관지가 약한 편이므로 독감/폐렴 예방접종을 권고합니다.

소아의 경우 : 폐암, COPD는 배제할 수 있습니다.

2세 이하의 소아가 기침, 호흡곤란, 천명음 등을 보일 경우 **급성 세기관지염**을 의심해 볼 수 있습니다. 반면에 쾃깅거리는 기침과 함께 신 목소리를 낼 때 **크룹**을 의심해 볼 수 있습니다. 학동기의 환아가 열, 두통, 인후통, 다형홍반, 기침 등의 증상을 보인다면 **미코플라즈마 폐렴**을 의심할 수 있습니다.

시험 관령 코멘트



콧물의 경우 알레르기, 감염, 비감염으로 나누어서 생각하는 것이 중요합니다. 콧물의 양상과 색깔 등을 파악하고, 어떠한 상황에서 콧물이 심해지는지 확인하는 것도 중요합니다. 신체 진찰 시 원인 질환에 해당하는 증상을 보이는지 잘 확인해야 하고, 비경이 있는 경우 잊지 않고 써야 합니다.

문진에서 약물의 경우 ACEi와 비충혈제거제 복용 여부를 확인하도록 합니다. 또한 부비동 압통의 경우 문진 상에서는 모른다고 하더라도 신체 진찰 상 카드를 주거나 압통이 있을 수 있으니 반드시 확인하도록 합니다.

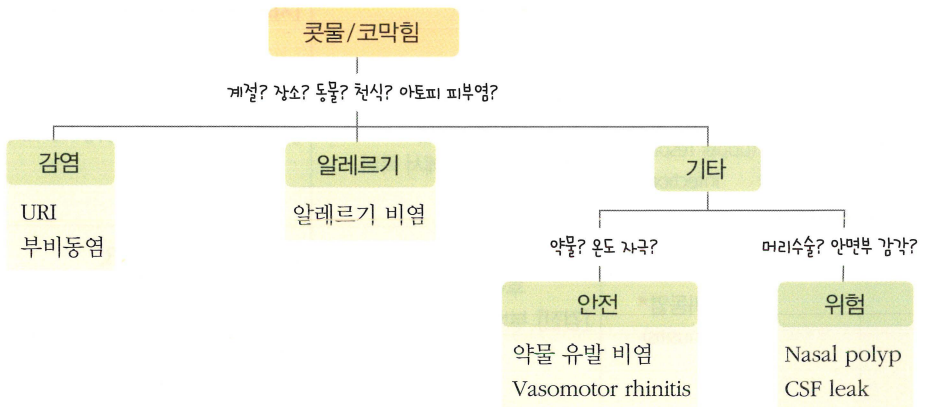
연습할 때 비경을 쓰는 방법을 알아 두어 시험장에서 당황하지 않도록 연습해 주세요. 환자 교육에서는 원인 질환에 따라 적절한 설명을 해야 합니다. 알레르기 비염이 원인인 경우 유발 요인 회피가 중요하며, 주변 환경을 잘 관리하는 것이 필요함을 교육해야 합니다. 환자에게 너무 무리해서 코를 풀지 않도록 교육하는 것도 필요합니다. 또한 이경 사용 시 SP 환자가 다치지 않도록 천천히 조심히 사용하도록 합니다.

질병별 진단 / 치료 계획 정리

계통	원인	질병	진단 키워드	검사/치료
코	알레르기	알레르기 비염★ (allergic rhinitis)	[병력] 맑은 콧물, 재채기, 가려움, 코막힘 [검진] 창백하고 부어 있는 비 점막	[검사] 코내시경, Skin prick test, Serum specific IgE, 혈액 호산구 [치료] 회피요법, 항히스타민제, 면역요법
	감염	상기도 감염 (upper respiratory infection)	[병력] 인후통, 기침, 가래, 코막힘, 발열 [검진] 구강 시진에서 목이 부어 있음	[검사] 후두경, CBC, CXR [치료] 휴식과 수분 섭취, NSAID, 항생제
		부비동염★ (sinusitis)	[병력] 코막힘, 호흡곤란, 후각 감퇴, 두통 [검진] 부비동 압통	[검사] 코내시경, CXR, 부비동 CT, PNS series, 후각검사 [치료] Amoxicillin, 코세척, 충혈제거제

코	비감염	혈관 운동 비염★ (vasomotor rhinitis)	[병력] 뜨거운 음식 먹을 때 맑은 콧물 [검진] 이상 소견 없음	[검사] PNS series, 후각검사, Skin prick test [치료] 회피요법, 항히스타민제, 비강 스테로이드
		부비동 종양	[병력] 한쪽에서만 나오는 콧물, 혈성, 방사선조사 이력, 코담배 [검진] 안면신경 감각 이상 등 다양함	[검사] 코내시경, 두경부 CT, MRI [치료] 수술, 방사선조사, 항암 치료
		뇌척수액 콧물 (cerebrospinal fluid rhinorrhea)	[병력] 두부외상력, 신경학적 이상 소견 [검진] 신경학적 이상 소견 있을 수	[검사] 두경부 CT, MRI [치료] Amoxicillin, 수술
		약물유발 비염 (drug-induced rhinitis)	[병력] ACEi, NSAIDs, 국소혈관수축제 [검진] 이상 소견 없음	[치료] 약물 중단 및 교체
		코외상/이물	[병력] 코 다치거나 이물질 들어간 적 [검진] 코외상 확인	[검사] 두경부 CT, MRI [치료] 코내시경, 수술

증례별 알고리즘



기본 진찰 사항

STEP 1 병력 청취

O	언제부터 콧물이 나오기 시작하셨나요?
L	양쪽 코에서 콧물이 나오나요?/아니면 한쪽에서만 나오나요? [양측성] 감염/알레르기/응고장애 [편측성] 이물질/치주 질환/외상/곰팡이 질환/종양
D	콧물이 얼마 동안 지속되나요? 하루에 몇 번 정도 콧물이 흐르나요? (횟수와 기간 묻기)
Co	콧물이 나오는게 점점 더 심해지시나요?
Ex	이전에도 이런 적이 있나요? → 치료는?
C	콧물의 양상(수양성/점액성) [맑고 투명] 감기 초기/알레르기/혈관 운동성 비염 양, 색, 냄새, 피 섞였는지? [노란 끈득] 감기 후기/축농증 [피] 외상/응고장애/곰팡이 질환/종양 [냄새(악취)] 축농증/이물질/종양 일상 생활에 지장이 있나요? 암기법 CAT, 냄새/피 설명 기침에서 가래 있을 때와 거의 비슷합니다. CAT를 통해 색, 양, 특성(수양성/점액성)을 물어봅니다. 이에 더해 냄새가 나는지, 피가 섞였는지만 더 물어봅니다.
A	*코부터 시작해 순서대로 물어보면 됩니다. 단, 순환기/소화기는 물어볼 필요 없습니다. 코 → 부비동 → 상기도 → 하기도 → 전신 설명 기침과 비슷합니다. 다만 콧물/코막힘은 순환기 및 소화기과의 관련성이 떨어지므로, 묻지 않습니다. 부비동 종양 감별을 위해 안면부 감각 저하를 물어보는 것을 유의합니다. [알레르기 비염] 재채기 하나요?/눈, 코가 가렵나요? [부비동염] 코 주위 압통/두통이 있나요?/냄새는 잘 맡나요? [호흡기-상기도] 기침/가래/코막힘/인후통 증상이 있나요? [호흡기-하기도] 호흡곤란/쌉쌉거림 [후비루증후군] 목 뒤로 콧물이 넘어가나요? [전신] 발열/오한/체중 변화/피로가 있나요?

F	최근에 감기에 걸리셨나요? [알레르기 비염] 특정 계절에 심해지나요?/특정한 장소에서 더 심해지나요? 반려동물을 키우시나요? [혈관 운동성 비염] 찬바람 쐬거나/뜨거운 음식이나 매운 음식 먹을 때 심해지나요? 압기법 감기 걸려 시동을 거니 차가 뜨거워졌다” → 감시동차뜨 설명 [감기] → 감기 걸렸나요? [사공간(특정 계절, 장소) + 동물] → 특정 계절, 장소에서 심해지나요? 반려동물 키우나요? [차고 뜨거움] → 찬 곳에서 심해지거나, 뜨거운 음식 먹을 때 심해지나요? 콧물/코막힘을 감별하기 위해 세 가지 영역으로 나누어 질문하며, 각 영역은 위에 쓰인 대로 묻습니다.
	E 건강 검진?/이전에 예방접종은 필요한 대로 다 잘 맞으셨나요?
외	[외상] 머리/코외상력/코에 이물질이 들어간 적 있나요? [수술] 머리 수술 받은 적 있나요?
과	이전에 진단받은 병이 있나요? (당뇨, 고혈압, 간염, 결핵) 어릴 때 알레르기 질환(아토피 피부염, 천식)
약	복용 중인 약물이 있나요? → ACEi, NSAIDs, 피임약, 국소혈관수축제
사	술, 담배/직업이 어떻게 되시나요? 근무 환경은 어떤가요?/집안 환경은 어떤가요? (먼지)
가	가족 중 알레르기/아토피 피부염
여	-
P/E	이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요? 오늘 측정한 활력 징후는 정상입니다(이상 소견이 있는 경우 언급해 주기!). [앉아서] 1. 눈 : Allergic shiner(알레르기 비염), Racoon eyes(외상의 징후) 유무 시진 2. 입 : 구강 발적, 편도 비대, 후비루, 염증 소견 3. 코★ : Transverse crease, nose swelling 유무 시진, 콧물 성상 및 비점막 상태, 콧물 흐르는 부위 확인 → 비경 사용 4. 부비동 : 압통 확인 5. 목 : 경부 림프절 촉진(종양, 감염) 6. 흉부 진찰★ : 흉부 시-촉-타-청 7. 사지 : 곤봉지, 청색증
술기	[임상 술기] 모형이 준비되어 있음 1. 이경검사 → 협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 것은 없으신가요?

STEP 2 환자 교육

공감	그동안 콧물이 많이 흐르셔서 불편하시고 걱정되셨겠습니다.
추정 진단	지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때, 현재 알레르기 비염이 가장 의심됩니다.
감별 진단	하지만 이 외에도 혈관 운동 비염이나 부비동염도 완전히 배제할 수 없습니다.
검사	따라서 정확한 진단을 위해 코내시경과 피부단자검사, 부비동 X-ray가 필요할 것으로 보입니다. 괜찮으신가요?
치료	만약 검사로 알레르기 비염이 확진되면 치료를 위해 항히스타민제와 비강 내 스테로이드가 필요할 수 있습니다. 그리고 환자분께서 많이 불편하시다면 장기적인 완치 요법인 면역요법을 시행해 볼 수 있습니다. 어떠신가요?
예후	지금부터 잘 치료를 받으시면 호전되실 수 있습니다. 증상이 있을 때 병원에 잘 오셨습니다.
교육	[알레르기 비염] 원인을 회피하는 것도 매우 중요합니다. 코막힘이나 콧물을 유발하는 상황을 숙지해 놓았다가 이를 피하시는 습관을 들이시면 좋습니다. [환경 관리(알레르기 질환)] 알레르기 질환이 있을 경우 주변 환경을 잘 관리하는 것이 중요합니다. 집안 청소를 자주 하시고, 이불, 매트리스 커버를 주 1회 섭씨 55℃ 이상 뜨거운 물로 세탁하신 뒤 말려서 사용하시길 바랍니다. 실내 습도는 40~50%로 유지하여 집먼지진드기의 번식을 막으셔야 합니다. [혈관 운동성 비염] 이 질병은 알레르기 비염의 가능성이 제외되면 진단할 수 있습니다. 먼저 콧물을 유발하는 요인들, 추운 곳에 가시거나 뜨거운 음식을 드시는 등의 행동을 회피하시는 것이 좋습니다. 그리고 증상이 심한 경우에는 국소 항콜린제를 필요시마다 분무할 수 있고, 그 외 코막힘이 심하면 항히스타민제 등 약물 치료를 할 수 있습니다.
질문	마지막으로 혹시 궁금한 점이 있으신가요?

❖ 기본적 진단 계획

- ① Water's view X-ray(PNS series), Facial CT
- ② 비경검사, 비내시경(nasal endoscopy)
- ③ Skin prick test, RAST(specific IgE)

❖ 치료 계획

- ① 알레르기 비염 : 회피요법, 항히스타민제, 비강 스테로이드 분무
- ② 부비동염 : 항생제
- ③ 혈관 운동성 비염 : 유발시키는 인자 피하기, 비강분무법(항콜린제, 항히스타민제)
/국소 혈관수축제

❖ 환자 안내/생활 습관 교육

- ① 알레르기 유발 요인 회피(천 덮인 가구, 카펫 집에서 제거, 이불 54℃ 이상 주
1~2회 세탁, 습도 50% 이상 유지, 애완동물 안 키우기, HEPA filter 청소기)
- ② 금연 교육/독감 예방접종
- ③ 감기인 경우 손위생 철저히 관리하도록 교육하고, 중이염, 부비동염, 폐렴 등의 합병증이 의심될 경우 즉시 재방문 교육
- ④ 비충혈제거제를 2일 이상 사용할 경우 완화 후 다시 막히는 악순환이 반복됨을 설명
- ⑤ 부비동염 : 단순 감기와 달리 항생제를 꼭 쓰고, 비충혈제거제를 끊어야 함



keyword

알레르기, 감염, 비감염으로 나누어 생각하기

약물이 증상을 유발할 수 있으므로 ACEi와 비충혈제거제 복용 여부 확인하기
알레르기 비염이 의심될 경우 원인 물질 회피 및 주변 환경 관리 교육하기
손 위생 및 코를 세게 풀지 않도록 교육하기